Module 2 : caractéristiques des personnes PA

Cours 5 : Besoins diversifiés des PPA

Objectifs :

- Nommer et expliquer les différents besoins des personnes proches aidantes.
- Expliquer l'importance de l'utilisation d'un outil d'évaluation des besoins des personnes proches aidantes.
- Identifier les enjeux reliés à l'implantation d'un outil d'évaluation destiné aux personnes proches aidantes dans le réseau de la santé et des services sociaux.
- Connaitre ce qui se fait ailleurs en matière d'évaluation des besoins des proches aidants

PPT narré :

- 15 min

Vidéo :

- Proches aidants, la face cachée de la santé (29 min)
- https://www.youtube.com/watch?v=95skiRepSVE

Lectures (20 pages) :

- Barylak, Guberman, Fancey, Keefe (2006) : Retour sur l'utilisation de l'outil d'évaluation des Pa – p.6 à 21 (section 1-2)
- Guberman (2014) : L'outil aide-proche pour évaluer les besoins des aidants – p.1
- Lévesque, Ducharme, Caron (2010) : L'ESPA – p.1 à 4

Sites à connaître (à titre informatif) :

- https://www.lappui.org/fr/je-suis-aidant/etre-proche-aidant/me-preserver-pour-mieux-aider/
- https://www.lappui.org/fr/je-suis-aidant/etre-proche-aidant/faciliter-mon-quotidien/guides-pour-les-proches-aidants/
- https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/medium-large/segments/entrevue/45116/proches-aidants-pour-davantage-maisons-gilles-carle-orsini-blais-sainte-marie

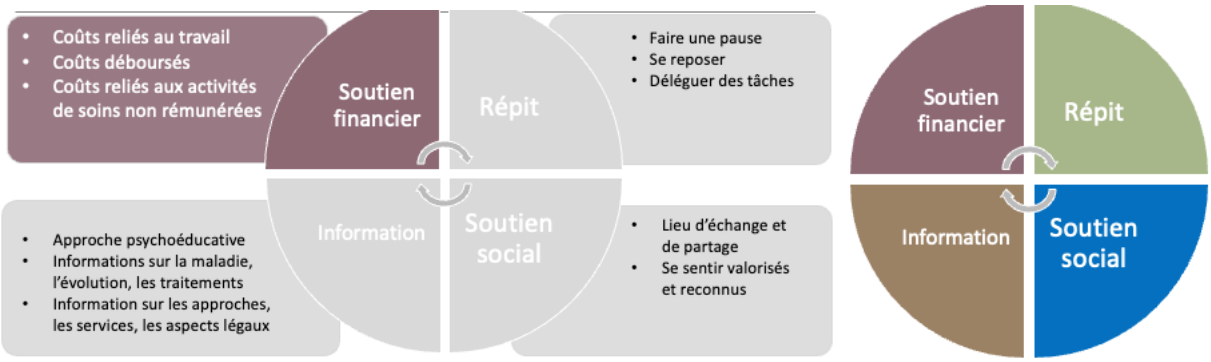
Besoins des PA

Les principaux besoins des PA , santé CAN 2005 (peu importe le types de PA et ces besoins doivent évoluer dans le temps)

1. **Soutien financier**
    - **Couts reliés au travail**
        - Perte de revenu
        - Diminution de la productivité
        - Perspective de carrière qui change
    - **Couts déboursés**
        - Dépenses pour la personne à charge
        - Dépenses pour l'aide nécessaire
        - Transfert d'argent, cout de déménagement, les transports, le stationnement, etc.
    - **Couts reliés aux activités de soins non rémunérées**
        - Temps consacré aux soins
        - Temps non disponible pour la personne aidante (ce qui ne peut pas être fait pcq aidant aide aidé)
2. **Répit**
    - **Faire une pause**
    - **Se reposer**

        - On offre aux aidants un service de relève, soit qqu'un pour le remplacer auprès du proche aidé
    - **Déléguer des tâches**

3. **Soutien social**
    - **Lieu d'échange et de partage d'informations et d'expériences**
        - Permet de briser l'isolement
        - Permet d'enrichir les connaissances
        - D'universalisé le problème
        - Prévenir l'épuisement
        - Rencontre de gens qui ne sont pas dans le milieu familial, donc d'agrandit le réseau social et d'accéder a d'autres vision de la maladie et façon d'intervenir auprès du proche
        - Effet bénéfique de discuter de leur réalité +/- avec leur proche aidé
    - **Se sentir valorisés et reconnus par les autres**
        - Les PA ne se sentent pas considéré et reconnus par l'équipe multidisciplinaire traitante, donc ne se sentent pas consulté lors des prises de décisions importantes concernant leur proche aidé
        - Les PA sentent qu'ils n'ont pas de valeur auprès du système de santé
        - Certains pays ont des lois et politiques pour reconnaître le rôle de PA, ce qui les valorisent socialement dans leur rôle
    - Il devrait arrivé au début du parcours de PA en guise de prévention et non lorsqu'il est à la fin du rouleau
4. **Information**
    - **Approche psychoéducative**
    - **Information sur la maladie, l'évolution, les traitements**
    - **Information sur les approches, les services, les aspects légaux, la gestion de trouble de comportement**
    - Le besoin d'information peut être jumelé au soutien social et ce faire dans le cadre de groupe, de discussion, groupe soutien/entraide (offre donc info + soutien)



- La majorité des services au PA offert au QC reposent sur ces 4 besoins, d'où l'importance de les connaître.

Outil d'évaluation des besoins des PA

- Sur le terrain, depuis 20ans dans la littérature on lit qu'il faudrait systématiquement évaluer les besoins des PA. En aucun cas, dans le réseau, ses besoins sont évalués. Même si on sait et reconnaît qu'il a besoin de répis, slm si le PA demande qu'on le réfère.
- **Actuellement dans réseau de la santé, seul l'aidé est évalué.**

Bref, on n'évalue pas les besoins des PA dans le réseau de la santé

- On évalue les besoins de l'aidé, on voit comment les PA peuvent répondre à ces besoins. (ex. besoin d'entrée dans le bain ? Voici comment le PA vous pouvez aider !) (charge de responsabilité sur le PA)
- On cherche à savoir, ensuite, si le PA peut payer les services qui manque ou qui ne peut faire lui-même. (ex. est-ce qu'il peut acheter du matériel pour entrer dans le bain, comme des bancs d'appui ou payer qq'un pour le faire à sa place, alors on le réfère aux services privés dont le PA a besoin, si non on tente de le référer aux organismes communautaires ou entreprise d'économie social pour l'aider) (charge financière sur le PA)

Préalables à l'évaluation des besoins des PA Si on veut construire une outil pertinent pour évaluer les besoins des PA, il faut prévoir ceci :

- **Prévoir une évaluation distincte**
  (MSSS, 2003, MSSS, 2012)
  - Ceci nécessite un dossier distinct
- **Réévaluer à différents moments de la trajectoire considérant les changements des besoins**
  (ACSP, 2013; Byrne, 2016; RANQ, 2018)
- **Associer l'évaluation des besoins au développement de services et mesures de soutien**
  (Ducharme et al, 2010)
  - Elle doit évoluer et se développer en fonction des besoins des PA
- **Utiliser un outil capable de s'adapter aux diverses situations**
  [Byrne, 2016; Ewing et Grande, 2013; RANQ. 2018)
  - L'évaluation doit être flexible, considérant les multiples profils de PA, donc s'adapter tant aux hommes qu'aux femmes, aux autochtones, aux adolescents, etc.

Ce que les 2 outils (aide-proche & ESPA) comprennent (outils pour évaluer les besoins des PA au QC)

- **Aide-proche :**
  - vise à évaluer les besoins des PA
  - conçu par des intervenants sociaux
- **ESPA :**
  - on vise un partenariat aidants – infirmière afin d'établir une entente pour que les services répondent au soutien/besoin souhaité
  - conçu par des infirmières (explique la différence d'approche entre les 2 outils, ainsi que le but des outils)

1. **Outil AIDE-proche**

(Barylack, Guberman, Fancey et Keefe, 2006)

- Le travail de soins
- Les relations avec les services formels
- Les relations aidants-aidés-famille
- La santé de l'aidant
- La conciliation des rôles
- Le logement
- Les coûts financiers de l'aide
- La planification des soins

2. **Outil ESPA**

(Lévesque, Ducharme et Caron, 2010)

- Les besoins d'aide pour prendre soin du parent
- Les besoins d'aide pour améliorer la qualité de vie du parent

- Les besoins d'aide pour améliorer la qualité de vie de l'aidant
- Les caractéristiques de l'aide de qualité

Question de réflexion

- Quels sont les avantages d'une évaluation formelle des besoins des proches aidants ? (à partir des lectures et réflexions personnelles)

Avantages d'une évaluation des besoins (Barylack, Guberman, Fancey et Keefe, 2006)

1. **Proches aidants**
   - Raconter son histoire
   - Analyser ses besoins
   - Effectuer une introspection (forces et faiblesses)
   - Obtenir une reconnaissance pour ce qu'ils font
   - Réduire le fardeau des aidants et atténuer les effets négatifs de la dispensation des soins (prévention)
2. **Pratique**
   - Prévenir ou atténuer des effets négatifs associés au rôle d'aidant.
   - Permettre aux intervenants d'aider les aidants.
   - Informer et sensibiliser les intervenants aux besoins des aidants.
3. **Prévention / sensibilisation**
   - Entendre les histoires des aidants.
   - Déterminer les plans de services selon les besoins de l'aidant et non juste de l'aidé.
   - Reconnaitre que les besoins de l'aidant sont différents.
4. **Organismes**
   - Maximiser le rendement de l'argent attribué aux aidants.
   - Prendre de meilleures décisions : quand, comment et pourquoi utiliser quelles interventions.

Question de réflexion

- Quelles sont les limites des outils d'évaluation des besoins des proches aidants ?

Limites des outils d'évaluation des besoins Qc

1. **AIDE-proche** (Barylack et al, 2006)
   - L'évaluation des besoins de l'aidant doit être une priorité dans l'organisme
   - Requiert trop de temps pour le compléter dans le contexte des soins à domicile
   - Certaines sections redondants (déjà évaluées ailleurs)
   - Difficile d'utilisation
   - Ne répond pas aux attentes des aidants

Trouver un outil parfait pour reconnaitre les besoins des PA est difficile.
Les 2 outils sont complémentaires et ce ressemble un peu, mais ne sont pas parfait.
Les limites des 2 :
-ils sont long à utiliser
-et la liste des besoins pourrait ne pas être identifié en raison du manque de ressource.
Il faut donc revoir l'organisation du travail, diminuer la charge de cas.

2. **ESPA** (Ducharme et al., 2010)
   - Craintes de créer des attentes chez les aidants que les services de soins à domicile ne pourraient combler dans le contexte actuel du manque de ressources
   - Requiert trop de temps pour le compléter dans le contexte des soins à domicile actuel
   - Intervenants se sentent démunis de ne pouvoir répondre aux besoins identifiés

Implantation d'un outil d'évaluation des besoins des PA

D'où vient l'idée d'évaluer les besoins des proches aidants?

- **Politique de soutien à domicile ''Chez soi, le premier choix'' (2003)** (la 1er politique date de 1979)

- « Le proche-aidant est considéré à la fois comme un client des services, un partenaire et un citoyen qui remplit ses obligations usuelles.
- **Un client des services :**
  - Le proche-aidant a besoin d'appui et d'accompagnement pour remplir son rôle. Une gamme de services et des mesures visant à appuyer les proches-aidants doivent être graduellement mises en place dans chaque région pour répondre à leurs besoins propres.
- **Un partenaire :**
  - Le proche-aidant doit recevoir toute l'information (avec le consentement préalable de la personne qu'il aide), la formation et la supervision nécessaires pour maîtriser les tâches qu'il accepte librement d'effectuer ; il doit également savoir à qui s'adresser en cas d'urgence et avoir accès à une aide immédiate. Dans les services de longue durée, le proche-aidant participera activement à l'élaboration du plan d'intervention ou du plan de services individualisé, toujours si la personne ayant une incapacité y consent.
- **Un citoyen :**
  - qui remplit ses obligations sociales et familiales. Des mesures doivent être prévues pour le proche-aidant dans ses obligations normales et habituelles (normes du travail, assurance emploi, mesures fiscales…) ». (p.6-7)

- **Mesurer les besoins :**
  - « L'outil multi clientèle doit évoluer au cours des prochaines années pour […] **Mesurer les besoins propres des proches-aidants** (en fonction de leurs attentes et de caractéristiques comme l'âge, le sexe, des conditions de vie particulières, etc.) ». (p.18)
    - Malheureusement, en 2020 on a pas encore rempli ce mandat. Excellente politique sur papier, mais n'a jamais été mise en œuvre.
- **Réévaluation annuelle :**
  - « La situation de toute personne ayant une incapacité significative et persistante et celle des **proches-aidants doivent être réévaluées au besoin, au minimum une fois par année »**. (p.18)

Question de réflexion

- Quelles sont les résistances envers l'évaluation des besoins des proches aidants? Donc pourquoi on évalue pas leurs besoins ?
  - Raisons économiques, politiques, pratiques

Évaluation des besoins des proches aidants ailleurs dans le monde

Ailleurs dans le monde

- **Manitoba (Canada)** : Caregiver Recognition Act/Loi sur la reconnaissance de l'apport des aidants naturels (2011)
  - Prévoit une description et une analyse des besoins des aidants et des mesures de soutien existantes
- **France** : Loi sur l'adaptation de la société au vieillissement (2016)
  - Mentionne que l'évaluation prendra en compte les besoins du bénéficiaire et du proche aidant.
- **Suisse :** Plan d'action de soutien et de décharge en faveur des proches aidants (2014)
  - Vise à « aménager des prestations répondant aux besoins des proches aidants afin de leur permettre de s'occuper durablement d'une personne dépendante en évitant autant que possible une charge difficilement supportable pour les familles ».
- **Irlande :** Carers and Direct Payments Act (2002)
  - Stipule que les besoins des proches aidants doivent toujours être évalués, qu'il faut subvenir à leurs besoins et prévoir un soutien financier pour aider quotidiennement les proches aidants.
- **Royaune-Uni** : Carers Equal Opportunities Act (2004) = a la palme d'or dans ce domaine

- Vise à bonifier l'évaluation des besoins des proches aidants de la loi précédente (*Carers and Disabled Children Act,* 2000)
- **La loi oblige …**
  - La loi oblige les autorités locales à informer les proches aidants de leur droit à une évaluation de leur besoin
  - La loi oblige les évaluateurs à une veille en ce qui concerne le travail, l'apprentissage et les loisirs des proches aidants, c'est-à-dire que l'évaluateur doit prendre en compte dans les besoins du proche aidant son désir, s'il y a lieu, de travailler, d'aller à l'école ou d'avoir des loisirs.

Vidéo – PA, la face cachée de la santé (30 min)

- Suisse
- 1h travail professionnel – 6 à 7h de travail PA

Gilbert PA de Berthy

- Depuis 10 ans, Gilbert s'occupe quotidiennement de sa femme Berthy qui est hémiplégique à la suite d'un accident cardiovasculaire cérébral.
- Il est devenu PA pour éviter sa femme d'aller dans un institut spécialisé vu son AVC.
- Travail constant, jour et nuit. Il n'y a pas d'arrêt. Cela fait 10 ans qu'il n'a pas eu un jour d'arrêt, mais tjrs avec plaisir.
- Il accompagne sa femme partout, y compris lors de soins médicaux.
- Il s'occupe du transfert de sa femme (ex. d'une chaise à une autre) pour éviter qu'elle tombe. Il préfère le faire pcq'il a vu sa femme tombée plusieurs fois déjà par des gens qui sont qualifiés mais méconnaissant des transferts.
- Il est présent lors des soins, il est intégré. Il connaît très bien sa femme et le personne s'y est habitué. Le médecin sait la traité, mais Gilbert sait la faire vivre. Autrement dit, il a un rôle essentiel et spécifique de PA.
- **Il témoigne devant des soignants afin de réfléchir à la meilleure manière d'intégrer le PA.**
  - Comment intégrer une tierce personne avec le personnel soignant à l'hôpital ?
  - Les soignants sont les spécialistes des soins physiques, alors que le PA est le spécialiste pour le confort moral de la personne.
  - Le but n'est pas de prendre la place de l'infirmier.
  - Cela bouleverse les pratiques de l'hôpital, qui sont habituer la relation soigné-soignant (2 personnes).
  - Travailler à 3 nécessite un consensus
  - On commence par l'identification, à l'hôpital, du PA. (définition peu connu). On propose alors une carte qui va l'identifier. Ceci étant dit, ce n'est pas un statut de PA via la reconnaissance de leur rôle par l'entremise de la politique. La carte est plutôt symbolique.
- **Selon Gilbert, on ne peut pas payer ce qu'il fait en tant que PA.**
  - Ce serait, selon lui, un salaire énorme à celui qui devrait le payer.
  - Ce qui serait approprié, ce serait une petite indemnité de l'état (reconnaissance à ceux qui lui économise bcp de sous.)
  - Présentement, ils vivent avec L'AVS et l'allocation de la potence comme revenu.

Françoise PA de Roxanne

- Roxanne petite fille atteinte d'une maladie chronique de la peau (plaies multiples)
- Parents et 2 grands-mères se relaient toute la semaine pour effectuer les soins minutieux de ses blessures.

- Les soins à Roxanne, selon l'humeur/douleur de Roxanne, environ 1-1h30. Parfois, le soin ne peut se faire en 1 fois. Il faut couper en utilisant des trucs, comme aller prendre une marche, aller jouer (changer les idées). Autrement dit, du sur mesure que des soins professionnel à domicile ne pourrait pas offrir faute de temps. Ce que les g-m ont, du temps. Les choses se font dans le confort, la tranquillité, pas de stress (qui impact Roxanne).
- La familiarité et la proximité, c'est ce qui rend les PA irremplaçables.
- Pour Françoise, c'est naturel de s'occuper de Roxanne (''ça va de soi''), ainsi elle ne se sent pas PA. Toutefois, ce que ça implique que son rôle familial de g-m, ce qui n'est pas évident à s'avouer.
- Il faut qu'il y ai une prise de conscience sur leur statut d'aidant (cesser de dire ''c'est naturel'').

Le programme ''ensemble''

- Programme complémentaire à ce qui se fait déjà.
- Uniquement pour le PA (le patient, l'aidé n'est donc pas présent)
- Les PA peuvent vivre de la dépression, de l'anxiété, de la somnolence…bref risque sur leurs vies.
- Permet à l'aidant à penser à lui, à écouter ses émotions ce qui a un impact positif (''Fait du bien'').
- Au centre se situe l'aidé, et autour les aidants.
- Ensemble offre des exercices pratiques. (c'est du concret pour des situations concrètes)
    - Ex. pleine conscience
- Impact sur la qualité de l'engagement, mais pas sur la quantité. Ce que le PA fait, il comprend mieux pourquoi il fait. Donc impact positif entre la relation de l'aidé et du PA. (échanges facilités)

Victoria et sa famille

- Victoria est atteinte d'un cancer (leucémie)
- Depuis 4 mois, la famille vit au rythme des hospitalisations et des traitements successifs
- Dans la chambre d'hôpital il y a un lit pour le parent. (on comprend la nécessité de la présence du proche au pied du lit de l'enfant malade)
- Son état est allé assez rapidement, générant de l'incompréhension, de la peur, bref peu de temps pour réfléchir. Autrement dit c'est bcp d'émotions.
- La mère a du arrêté de travail afin de soutenir à chaque jour sa fille à l'hôpital.

Belma et sa famille

- Elle est née avec la leucémie (cas rare)
- Suite à une greffe de moelle osseuse, elle grandit dans une chambre stérile.
- Les 2 parents ont pris un arrêt de travail, vont régulièrement à l'hôpital qui n'est pas proche ce qui impact leur autre enfant en jeune âge qui voit très peu ses parents.
- Le père amène son fils à l'école, retourne chercher son fils et l'amène chez ses parents. Il se couche et on recommence.
- Vivre à l'hôpital c'est difficile pour les parents, ça leur demande de l'adaptation.
- La compréhension de la maladie via les informations qu'on fournit l'hôpital est nécessaire. Ca facilite le quotidien de comprendre ce qui ce passe.

Enzo

- Traitement de chimiothérapie
- Les parents n'arrivent pas à dormir dans la chambre de leur enfant : machine qui sonne, etc.
- La mère cuisine dans l'hôpital dans une cuisine spécial pour PA. Autrement dit, la mère s'organise pour faire plaisir à son fils.

- Les parents sont essentiel au service, ils font partie de l'équipe lors de soin. Cela exige donc une bonne communication entre les diverses parties.

Problématique

- Rester auprès de l'enfant, l'accompagner et le guérir ce sont les seules choses dont pensent les parents accompagnant leur enfant malade.
- **Comment y arrive-t-on quand la loi accorde 3 jours de congés par an ?**
    - Les parents peuvent faire des arrêts de travail (offert par le médecin)
    - Quand les employeurs sont compréhensif, ainsi que les assureurs, les familles arrivent à faire face. Il y a aussi des associations/fondations.
    - Mais si la maladie perdure, le parent devra quitter son emploi. Un risque de précarisation.
    - Il existe une prestation de répit (accompagnement à domicile pour limiter les impacts de la maladie sur la fratrie)
- **Si le problème n'est pas financier, la famille nucléaire s'en voit fragilisée.**
    - Soutenir son enfant dans la maladie (cancer) c'est un marathon qui nécessite le soutien des proches et de la famille.
    - Il existe de l'aide pour les PA (programme ensemble)
- **Risque de rechute pour tous les cas plus haut**
    - Vivre au jour le jour
    - Le quotidien impacter pour certain

Références

Altintas, E., Gallouj, K. et Alain, G. (2012). Soutien social, dépression et estime de soi chez les personnes âgées : les résultats d'une analyse en cluster. *Annales Médico-psychologiques revue psychiatrique 170*(4):256-262, DOI: 10.1016/j.amp.2011.10.015

Amieva H. et al. (2012). Attentes et besoins des aidants de personnes souffrant de maladie d'Alzheimer. *Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique, 60* (3):231–238 DOI: 10.1016/j.respe.2011.12.136

Barylak, L., Guberman, N., Fancey, P. & Keefe, J. (2006). *Retour sur l'utilisation de l'outil d'évaluation des proches aidants : les obstacles, les résultats et les répercussions de la politique.* 1-56. https://www.msvu.ca/wp-content/uploads/2020/05/Report-FR-2006-08-28_1.pdf

Belle, S.H., Zhang, S., Czaja, S.J., Burns, R. et Schulz, R. (2004). Use Cognitive Enhancement Medication in Persons with Alzheimer Disease who Have a Family Caregiver. Result from the Resources for Enhancing Alzheimer's Caregiver Health (REACH) Project. *American Journal of Geriatric Psychiatry*, *12* (3), 250-257.

Byrne, K. (2016). Family caregiver assessment in health care settings literature review and environmental scan project. The Change Foundation. https://bit.ly/2wvceuj

Coe, N. B. et Van Houtven, C. H.. (2009). Caring for mom and neglecting yourself? The health effects of caring for an elderly parent. *Health Economics Review, 18* (9), 991-1010. DOI: 10.1002/hec.1512

Ducharme, F. et al. (2010). Mise à l'essai d'un outil d'évaluation des besoins de soutien des proches - aidants d'un parent âgé à domicile : un outil ayant un potentiel d'application en Europe francophone. *Recherche en soins infirmiers (101*), 67-80. https://doi.org/10.3917/rsi.101.0067

Dunbrack, J. (2005). Les besoins d'information des aidants naturels qui apportent soutien à un proche gravement malade. Rapport de synthèse préparé pour Santé Canada. https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/hcs-sss/alt_formats/hpb-dgps/pdf/pubs/2005-info-caregiver-aidant/2005-info-caregiver-aidant-fra.pdf

Ewing, G. et Grande, G. (2013). Development of a Carer Support Needs Assessment Tool CSNAT) for end-of-life care practice at home: A qualitative study. Palliative Medicine, 27(3), 244-256. https://doi.org/10.1177/0269216312440607

Koopmanschap, MA et coll. (2004) The desire for support and respite care: Preferences of Dutch informal caregivers. *Health Policy 68*(3), 309-320. DOI: 10.1016/j.healthpol.2003.10.002

Guberman N., Keefe J., Fancey, P. & Barylak, L. (2007). Not another form!!: lessons for implementing Caregiver Assessment in Health and Social Service Agencies. *Health and Social Care in the Community, 15* (6), 577-587. DOI: 10.1111/j.1365-2524.2007.00718.x

L'Appui pour les proches aidants d'aînés (2016). *Portrait statistique des proches aidants de personnes de 65 ans et plus au Québec, 2012*.

Lévesque, L., Ducharme, F. & Caron, C. (2010). L'ESPA… pour mieux soutenir les aidants. *Perspective infirmière*, *7*(4), 42-46.

McAlister (2013). Valoriser les proches aidants et leur travail : le rôle des aidants naturels dans l'approche palliative intégrée. Association canadienne de soins palliatifs (ACSP). Association canadienne de soins palliatifs (ACSP). http://www.hpcintegration.ca/media/37046/twf-valuing-caregivers-report-final_fr-2.pdf

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). (2003). *Chez soi : Le premier choix. La politique de soutien à domicile.* Gouvernement du Québec : Direction des communications. https://bit.ly/3cQcB3z

Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS). (2012). *Vieillir et vivre ensemble : Chez soi, dans sa communauté, au Québec : historique de la première politique gouvernementale sur le vieillissement.* http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2250147

Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) . (2018). Mémoire présenté à la Commission de l'économie et du travail lors des consultations particulières sur le Projet de loi no 176. https://bit.ly/2TkJs92

Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ). (2018). Valoriser et épauler les proches aidants, ces alliés incontournables pour un Québec équitable. Stratégie nationale de soutien aux proches aidants. https://bit.ly/3crHVp5

Swartz, K., Colins, L. G. et Jefferson, T. (2019) Caregiver care, *American Family Physician.* 99(11), 699-706. https://www.aafp.org/afp/2019/0601/p699